Autismo: O Que Não Contaram às Famílias



Um guia crítico para mães, pais e familiares que desejam decidir sem medo, sem culpa e sem submissão ao discurso único.

LÚCIO ESCOBAR

Autismo:
O Que Não Contaram às Famílias

Um guia crítico para mães, pais e familiares
que desejam decidir sem medo, sem culpa
e sem submissão ao discurso único.

Lúcio Escobar

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Escobar, Lúcio
E74a Autismo: o que não contaram às famílias : um guia crítico para mães, pais e familiares que desejam decidir sem medo, sem culpa e sem submissão ao discurso único / Lúcio Escobar. -- 1. ed. -- São Paulo : Edição do Autor, 2025.
57 p. ; 29,7 cm.

Bibliografia.
Inclui índice.

1. Autismo - Aspectos psicológicos 2. Psicanálise 3. Mães – Experiências 4. Familiares - Orientação 5. Diagnóstico - Crítica ao discurso hegemônico I. Título.

CDD 618.92 CDU 616.896-056.36

Índice para catálogo sistemático:

1. Autismo : Aspectos psicológicos : Medicina e saúde 618.92
2. Autismo : Pessoas com deficiência : Medicina e saúde 616.896-056.36

Elaborado por Bibliotecário(a) Responsável – CRB-8/0000

Direitos autorais

Copyright © 2026 — Lúcio Escobar
Todos os direitos reservados.

Esta obra é protegida pela Lei nº 9.610/1998, que regula os direitos autorais no Brasil. O texto, título, subtítulo, estrutura, seleção de dados, análises, imagens, capa, diagramação e demais elementos editoriais pertencem ao autor.

A aquisição ou recebimento deste e-book autoriza apenas o uso pessoal, individual e intransferível. É proibida a reprodução total ou parcial, distribuição, venda, revenda, compartilhamento, adaptação, modificação, publicação ou disponibilização desta obra, por qualquer meio físico ou digital, sem autorização prévia e expressa do autor.

Também é proibido o compartilhamento do arquivo em grupos de WhatsApp, Telegram, redes sociais, sites, blogs, plataformas digitais, ambientes virtuais, drives públicos ou privados.

A violação de direitos autorais poderá gerar responsabilização civil e criminal. O art. 184 do Código Penal brasileiro prevê pena para quem viola direitos de autor, podendo chegar a reclusão de 2 a 4 anos e multa quando houver reprodução ou distribuição com intuito de lucro direto ou indireto.

É permitida a citação de pequenos trechos para fins de estudo, crítica, resenha ou divulgação, desde que sejam indicados o nome do autor, o título da obra e a fonte. Essa autorização não permite reprodução extensa, publicação integral, distribuição do PDF ou uso comercial.

Qualquer uso não autorizado poderá resultar em notificação extrajudicial, pedido de remoção de conteúdo, indenização por perdas e danos e demais medidas legais cabíveis.

Para solicitar autorização de uso, reprodução parcial, licenciamento, distribuição institucional ou utilização em cursos, aulas, formações e eventos, entre em contato previamente com o autor.

Lúcio Escobar
Todos os direitos reservados.

Índice

Introdução
Este livro não é contra tratamentos. É contra o discurso único.

Capítulo 1
Quem escolhe o que as famílias devem saber?

Capítulo 2
Quando o diagnóstico vira território de disputa

Capítulo 3
ABA: quando a ciência vira palavra de ordem

Capítulo 4
O que o discurso dominante esconde das mães

Capítulo 5
Como decidir sem medo: um guia crítico para famílias

Referências

Este Livro Não É Contra Tratamentos. É Contra o Discurso Único.

Uma mãe recebe o diagnóstico de autismo do filho. Muitas vezes, antes mesmo de conseguir elaborar o impacto da notícia, ela já é lançada em uma sequência de orientações, nomes técnicos, terapias, promessas e advertências. Dizem que é preciso agir rápido. Dizem que existe uma janela de oportunidade. Dizem que determinada terapia é "a mais científica". Dizem que, se a família não começar imediatamente, poderá comprometer o futuro da criança. Nesse momento, a mãe não recebe apenas uma informação clínica. Ela entra em um sistema.

Esse sistema é formado por médicos, terapeutas, clínicas, planos de saúde, escolas, influenciadores, associações, cursos, convênios, decisões judiciais, relatórios técnicos e campanhas de conscientização. Cada um desses lugares produz discursos sobre o autismo. Alguns discursos são repetidos tantas vezes que passam a parecer evidentes. Outros quase nunca chegam às famílias. O problema não é buscar tratamento. O problema não é procurar ajuda. O problema começa quando a família é colocada diante de uma única narrativa: a ideia de que existe apenas um caminho correto, uma única forma de intervenção legítima e uma única maneira de demonstrar cuidado.

Quando isso acontece, a dúvida da mãe passa a ser tratada como ignorância. A prudência vira atraso. A hesitação vira culpa. A pergunta vira ameaça. Este e-book nasce justamente para abrir espaço para essas perguntas. O objetivo não é substituir um dogma por outro. Não se trata de dizer que toda terapia é ruim, nem de afirmar que determinada abordagem nunca pode ajudar. O que será questionado aqui é outra coisa: a maneira como certas informações sobre o autismo são privilegiadas, repetidas e transformadas em verdade absoluta, enquanto outras informações — muitas vezes fundamentais — permanecem silenciadas.

Entre essas informações silenciadas estão os limites das pesquisas, os conflitos de interesse, as fragilidades metodológicas, os efeitos subjetivos das intervenções intensivas, a escuta dos próprios autistas e o sofrimento das famílias submetidas à lógica da urgência permanente. Falar em ciência exige responsabilidade. Mas responsabilidade científica não é repetir slogans como "padrão-ouro", "método comprovado" ou "única terapia com evidência". Ciência verdadeira também exige dúvida, comparação, revisão, crítica, transparência e reconhecimento dos limites. Por isso, este livro não é contra a ciência. Ao contrário: ele é contra o uso simplificado da ciência como instrumento de convencimento das famílias.

A mãe de uma criança autista não precisa ser conduzida pelo medo. Ela precisa de informação ampla, honesta e contextualizada. Precisa saber o que está sendo recomendado, por que está sendo recomendado, com base em quais estudos, com quais limites, com quais custos, com quais riscos e com quais efeitos possíveis sobre a vida da criança. Porque uma criança autista não é um conjunto de comportamentos a serem corrigidos. Ela é um sujeito. Tem corpo, linguagem, sensibilidade, recusas, invenções, medos, modos próprios de estar no mundo e formas singulares de laço. E nenhuma decisão terapêutica deveria apagar isso.

2,4M

Pessoas com TEA no Brasil

Diagnóstico registrado no Censo Demográfico 2022 do IBGE.

1,2%

Da População Brasileira

Prevalência total de diagnóstico de TEA identificada no Censo 2022.

1,4M

Homens Diagnosticados

Correspondendo a 1,5% da população masculina no Brasil.

1,0M

Mulheres Diagnosticadas

Correspondendo a 0,9% da população feminina no Brasil.

Autismo: Um Campo de Disputas

Quando falamos em autismo hoje, não estamos falando apenas de uma condição clínica. Estamos falando também de um campo de disputas. Há disputas sobre o diagnóstico, sobre o tratamento, sobre os direitos, sobre o lugar da escola, sobre a cobertura dos planos de saúde, sobre a autoridade dos especialistas e sobre o que deve ser considerado "evidência científica". Essa disputa aparece de forma silenciosa na vida das famílias. Ela aparece quando uma mãe escuta que precisa colocar o filho em muitas horas de terapia por semana. Aparece quando uma escola exige laudos para aceitar adaptações. Aparece quando um plano de saúde nega cobertura. Aparece quando uma clínica vende um pacote terapêutico como se fosse a única saída. Aparece quando a família é convencida de que qualquer recusa da criança deve ser superada por treino, insistência ou reforço.

É aqui que precisamos ter cuidado. O fato de uma intervenção apresentar resultados em alguns estudos não significa que ela deva ser aplicada do mesmo modo a todas as crianças. O fato de uma abordagem medir comportamentos não significa que ela compreenda toda a experiência subjetiva de uma criança autista. O fato de uma terapia ser chamada de "baseada em evidências" não elimina a necessidade de perguntar: que evidências são essas? Quantos estudos existem? Quem participou deles? O que foi medido? O que ficou de fora? Houve avaliação de sofrimento? Houve escuta da criança? Houve acompanhamento dos efeitos a longo prazo? Essas perguntas raramente aparecem nos discursos simplificados dirigidos às famílias.

No caso da ABA, por exemplo, é comum que ela seja apresentada como intervenção indiscutível. Muitas famílias escutam que ela é o "padrão-ouro" para o autismo. No entanto, revisões científicas importantes são muito mais cautelosas do que o discurso comercial costuma admitir. A revisão Cochrane sobre Intervenção Comportamental Intensiva Precoce, uma modalidade baseada em ABA, identificou apenas cinco estudos relevantes. A própria revisão afirma que os resultados devem ser interpretados com cautela, pois a qualidade da evidência é fraca, os estudos tinham poucos participantes e apenas um deles utilizava desenho ideal com randomização. Isso não significa que nenhuma criança possa se beneficiar de uma intervenção comportamental. Significa apenas que é cientificamente incorreto transformar evidências limitadas em promessa universal.

Uma família não deve ser obrigada a escolher entre "aceitar tudo" ou "rejeitar tudo". Existe uma terceira posição: decidir com informação, prudência e liberdade. Este livro foi escrito para sustentar essa terceira posição. Ele convida mães, pais e parentes de pessoas autistas a olharem para além das frases prontas. A desconfiarem das promessas absolutas. A perguntarem pelos dados. A investigarem o que não foi dito. A reconhecerem que cuidado não pode ser confundido com normalização. A compreenderem que uma criança autista não precisa ser domesticada para merecer lugar no mundo.

Ao longo dos capítulos, vamos examinar como certas verdades sobre o autismo são fabricadas, como o diagnóstico se tornou parte de um grande circuito institucional e econômico, por que a ABA precisa ser discutida com mais rigor, quais dimensões subjetivas costumam ser apagadas e como as famílias podem construir decisões mais informadas. A pergunta que atravessa este e-book não é: "qual terapia vence a disputa?" A pergunta é mais importante: o que acontece com a criança autista quando uma única forma de tratamento passa a falar em nome de toda a ciência?

Comparação Internacional

Brasil — Censo 2022: **1,2%** da população diagnosticada com TEA. EUA — CDC/ADDM 2022: **3,2%** das crianças de 8 anos identificadas. O dado brasileiro se refere a pessoas diagnosticadas no Censo; o dado americano refere-se a crianças de 8 anos na rede ADDM do CDC.

Faixa Etária no Brasil

Maior prevalência no Censo 2022: crianças de **5 a 9 anos**, com **2,6%** diagnosticadas com TEA. Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022.

⚠ **Atenção:** Dado estatístico não é ordem terapêutica. O aumento dos diagnósticos mostra a importância social do autismo, mas não prova que uma única intervenção deva ser aplicada a todas as crianças.

> Este e-book não pretende retirar das famílias a esperança. Pretende retirar delas a obrigação de obedecer ao medo.

Capitulo 1

Quem Escolhe o Que as Famílias Devem Saber?

Uma mãe entra em um consultório com uma suspeita e sai com uma palavra que reorganiza toda a vida familiar: **autismo**. A rotina muda. A escola muda. A forma de olhar para a criança muda. Mas junto com o diagnóstico não vem apenas uma explicação — vem uma urgência. A família é convocada a decidir sob pressão.

No Brasil, o Censo Demográfico 2022 identificou **2,4 milhões de pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista**, o equivalente a **1,2% da população brasileira**. Pela primeira vez, o Censo investigou diretamente a população com diagnóstico de TEA. Esse número mostra que o autismo passou a ocupar a escola, a família, o sistema de saúde, o Judiciário, os planos de saúde, as redes sociais e as políticas públicas.

Quando um tema cresce tanto, cresce também a disputa sobre quem tem autoridade para falar sobre ele. As famílias não recebem simplesmente "informação sobre autismo". Elas recebem informações já organizadas por um sistema que escolhe o que deve ser destacado, repetido, valorizado e financiado — e, muitas vezes de forma silenciosa, aquilo que será deixado de lado.

Informação Não Chega Pura Até as Famílias

Quando uma mãe escuta que uma terapia é "essencial", essa frase passou por livros, pesquisas, instituições, clínicas, planos de saúde, influenciadores, documentos técnicos, decisões judiciais e campanhas de conscientização. Cada instância organiza o autismo de uma maneira diferente.

Palavras que aparecem sempre

- Intervenção precoce
- Evidência científica
- Protocolo, comportamento
- Estimulação, intensidade
- Funcionalidade, evolução

Palavras que aparecem pouco

- Sofrimento, singularidade
- Recusa, subjetividade
- Escuta, vínculo, desejo
- Pausa, limite
- Tempo da criança

O conhecimento que chega às famílias privilegia aquilo que pode ser contado e medido. Comportamentos observáveis ganham destaque: a criança olhou mais? Sentou mais? Obedeceu mais? Falou mais palavras? Esses dados podem ser importantes, mas não dizem tudo. Uma criança pode parecer mais adaptada e ainda assim estar mais angustiada. Pode obedecer mais e brincar menos. Pode falar mais palavras e comunicar menos desejo. Quando apenas o comportamento visível é levado em conta, há sempre o risco de confundir adaptação com cuidado.

Dos 2,4 milhões de brasileiros com TEA, aproximadamente **1,4 milhão eram homens** e **1,0 milhão eram mulheres**. A prevalência foi maior entre homens (**1,5%**) do que entre mulheres (**0,9%**). Quanto maior o alcance social de um diagnóstico, maior também o poder dos discursos que passam a organizá-lo. Por isso, a pergunta fundamental não é apenas "o que é autismo?" — é também: **quem está ensinando as famílias a pensar o autismo?**

O Sistema que Fala Antes da Criança

Antes que a criança possa ser escutada em sua singularidade, muitas vezes o sistema já falou por ela. O laudo diz. A escala diz. O protocolo diz. A clínica diz. A escola diz. O convênio diz. O especialista diz. A criança, porém, pode ainda não ter sido verdadeiramente escutada.

A criança deixa de ser João, Ana, Miguel, Sofia ou Pedro. Ela passa a ser "nível 1", "nível 2", "verbal", "não verbal", "leve", "severo", "funcional", "com déficit", "com atraso", "com comportamento inadequado". A linguagem técnica pode ajudar, mas também pode apagar.

O que a mãe percebe	O que o sistema responde
Sofrimento, cansaço, recusa, medo, que a criança se apagou	Resistência, fuga de demanda, comportamento inadequado, necessidade de insistir, gráfico mostrando evolução

Muitas mães percebem isso antes dos profissionais. Sabem que o filho não é apenas um conjunto de sintomas. Sabem que há dias melhores e piores. Sabem que uma crise pode ter relação com barulho, sono, fome, medo ou mudança na rotina. Mas, frequentemente, a experiência da mãe é colocada em segundo plano diante da linguagem especializada. Esse é um dos efeitos mais fortes do sistema hegemônico: ele faz a família duvidar da própria percepção.

No Censo 2022, o grupo de **5 a 9 anos** apresentou a maior prevalência de diagnóstico de TEA no Brasil, com **2,6%**. Entre crianças e adolescentes, a prevalência foi maior do que entre adultos. Esse dado ajuda a entender por que tantas recomendações se concentram nos primeiros anos de vida. Mas ele não autoriza transformar a infância em um campo permanente de urgência e treinamento. Uma criança autista precisa de cuidado. Mas cuidado não pode significar invasão constante. Cuidar não é fazer o sistema falar mais alto que a criança.

Hegemonia Não é Conspiração

Quando este livro fala em sistema hegemônico, não está dizendo que existe uma conspiração secreta contra as famílias. Hegemonia é algo mais sutil e mais profundo: um discurso se torna hegemônico quando passa a organizar o modo como uma sociedade pensa determinado tema. Ele não precisa proibir todas as outras vozes — basta fazer com que algumas pareçam mais científicas, mais modernas e mais legítimas, enquanto outras passam a parecer ultrapassadas, fracas ou perigosas.

Palavras que dominam

Evidência, intervenção, comportamento, funcionalidade, treinamento, protocolo, desempenho, aquisição de habilidades

Como funciona

Transforma uma escolha histórica, política, econômica e institucional em algo que parece natural

O efeito nas famílias

A mãe sente culpa por perguntar. O pai sente que descansar é negligenciar. A família deixa de perguntar qual ciência, quais estudos, quais interesses estão envolvidos

A hegemonia funciona justamente assim: ela transforma uma escolha histórica, política, econômica e institucional em algo que parece natural. A mãe escuta tantas vezes que uma determinada intervenção é o caminho correto que começa a sentir culpa apenas por perguntar se há outras possibilidades. O pai escuta tantas vezes que a criança precisa de muitas horas semanais que passa a sentir que descansar é negligenciar. A família escuta tantas vezes que "a ciência diz" que deixa de perguntar qual ciência, quais estudos, quais limites e quais interesses estão envolvidos.

Nos Estados Unidos, o CDC mostra que aproximadamente **1 em cada 31 crianças de 8 anos** (**3,2%**) foi identificada com TEA pela rede ADDM, sendo mais de três vezes mais comum entre meninos do que entre meninas. Esses dados internacionais são frequentemente usados para mostrar o crescimento da identificação do autismo. Mas eles também mostram outra coisa: estamos diante de um campo global, atravessado por sistemas de vigilância epidemiológica, políticas de saúde, protocolos de intervenção, pesquisas, mercados e disputas de autoridade. Quanto mais o diagnóstico cresce em presença social, mais importante se torna perguntar quem organiza as respostas oferecidas às famílias. Uma coisa é reconhecer a importância do diagnóstico. Outra coisa é permitir que o diagnóstico seja capturado por um discurso único de tratamento.

O Nascimento da Urgência

Uma das formas mais eficazes de conduzir famílias é produzir urgência. Frases aparentemente simples têm grande impacto emocional — e atingem principalmente as mães, sobre quem costuma recair a maior parte da responsabilidade pelo cuidado.

"Você não pode perder tempo."

"Cada mês conta."

"Se não começar agora, depois será tarde."

"Sem intervenção intensiva, seu filho pode não desenvolver."

A mãe passa a sentir que qualquer pausa é abandono. Qualquer dúvida é risco. Qualquer questionamento é irresponsabilidade. É evidente que algumas crianças precisam de apoio precoce e que o acesso rápido a cuidados pode ser importante. O problema está em transformar essa necessidade em uma lógica de pânico. O pânico não ajuda a pensar — ele ajuda a obedecer.

Uma família em pânico tende a aceitar pacotes terapêuticos sem examinar detalhes, confiar mais na autoridade do profissional do que na própria percepção, suportar custos financeiros e emocionais altíssimos, e interpretar a recusa da criança como obstáculo ao tratamento, não como informação clínica importante. A urgência permanente também favorece o mercado: uma família assustada compra mais rápido, contrata mais rápido, aceita mais horas e questiona menos.

O dado brasileiro de que **1,1 milhão de pessoas de 0 a 14 anos** tinham diagnóstico de TEA no Censo 2022 mostra que grande parte da população identificada está na infância e adolescência. Esse número ajuda a entender por que o discurso da intervenção precoce se tornou tão forte. Há muitas crianças diagnosticadas, muitas famílias em busca de orientação e muitos serviços disputando esse campo. Mas dado populacional não é autorização para pressão emocional. O aumento dos diagnósticos exige ampliação do cuidado, sim — exige políticas públicas, formação profissional, inclusão escolar, suporte familiar e acesso a serviços. Mas não exige submissão ao medo. Uma mãe precisa de informação, não de chantagem emocional.

O que Vira Evidência e o que Fica Invisível

O que é facilmente mensurável

- Quantas vezes a criança olhou nos olhos
- Quantas palavras ela repetiu
- Redução de comportamentos registrados
- Tempo em atividade, obediência, imitação

O que tende a desaparecer

- Se o olhar foi espontâneo ou forçado
- Se ela conseguiu dizer algo próprio
- Aumento de angústia ou sofrimento silencioso
- Perda de espontaneidade, exaustão

No campo do autismo, uma das palavras mais repetidas é "evidência". Mas evidência não é uma palavra mágica — ela precisa ser examinada. Um estudo pode ter poucos participantes, amostra limitada, medir apenas determinados comportamentos, não acompanhar efeitos a longo prazo, não avaliar sofrimento, não escutar a experiência da criança. Pode apresentar melhora em uma escala e, ainda assim, não dizer quase nada sobre a vida subjetiva daquela criança.

> A pergunta científica mais rigorosa não é apenas "funcionou?" — é: funcionou para quem, em quais condições, com qual intensidade, durante quanto tempo, medindo quais resultados, deixando quais dimensões de fora e produzindo quais efeitos indesejados?

Quando essa pergunta não é feita, a palavra "evidência" pode se transformar em propaganda. É mais fácil contar quantas vezes uma criança olhou nos olhos do que compreender se aquele olhar foi espontâneo ou forçado. É mais fácil medir quantas palavras ela repetiu do que perguntar se ela conseguiu dizer algo próprio. É mais fácil registrar redução de comportamento do que investigar se houve aumento de angústia. Assim, um sistema inteiro pode se organizar em torno do que aparece no gráfico. Mas uma criança não cabe em um gráfico.

Os dados do CDC mostram a evolução da prevalência identificada de TEA em crianças de 8 anos nos Estados Unidos: em 2000, a estimativa era de aproximadamente **1 em 150**; em 2022, chegou a **1 em 31**. Esse crescimento costuma ser apresentado como sinal de maior reconhecimento do autismo. Mas também deve nos fazer pensar sobre o crescimento das estruturas associadas ao diagnóstico: clínicas, serviços, protocolos, custos, disputas legais e mercados de intervenção. Quando um campo cresce tanto, a palavra "evidência" se torna ainda mais poderosa — e, por isso mesmo, precisa ser interrogada com mais rigor.

O Diagnóstico como Senha de Acesso

Para muitas famílias, o diagnóstico de autismo não é apenas uma explicação. Ele é uma **senha de acesso**. Sem diagnóstico, a escola pode negar adaptação, o plano de saúde pode negar terapia, o Estado pode negar benefício. A criança pode ser tratada apenas como mal-educada, preguiçosa, agressiva ou desatenta. Nesse sentido, o diagnóstico pode ser muito importante — pode abrir direitos, proteger a criança e permitir que a família encontre recursos.

Mas existe uma armadilha. Quando o diagnóstico vira senha de acesso, ele também passa a ser disputado por diferentes instituições. A família precisa do laudo. A escola pede relatório. O plano de saúde exige justificativa. A clínica recomenda horas. O médico renova encaminhamentos. O terapeuta produz evolução. O advogado solicita documentação. O juiz avalia pedidos. O mercado oferece soluções. A criança passa a circular dentro de uma rede burocrática e terapêutica. Essa rede pode ajudar, mas também pode capturar.

760,8 mil

Estudantes com TEA

De 6 anos ou mais no Brasil (Censo 2022)

1,7%

Do total de estudantes

Com diagnóstico informado de autismo

66,8%

No ensino fundamental

508 mil estudantes com autismo estavam no ensino fundamental regular

Esses dados mostram a centralidade da escola no campo do autismo. A escola é, muitas vezes, o lugar onde o diagnóstico ganha consequências concretas: acompanhante, adaptação curricular, conflito com professores, reuniões, relatórios, inclusão, exclusão, judicialização. O risco é que a vida da criança passe a ser definida por documentos. Em vez de perguntar "quem é essa criança?", pergunta-se "qual é o nível de suporte?". Em vez de perguntar "o que ela está tentando comunicar?", pergunta-se "qual comportamento precisa ser reduzido?". Em vez de perguntar "como ela sofre?", pergunta-se "qual protocolo será aplicado?". O diagnóstico deve servir para abrir possibilidades, não para reduzir a criança a uma categoria. O nome clínico pode ser uma ferramenta. Mas não pode se tornar uma prisão.

O que o Sistema Mostra e o que Ele Esconde

Todo sistema de conhecimento mostra algumas coisas e esconde outras. No autismo, o sistema dominante mostra bastante o comportamento — se a criança senta, olha, responde, imita, aponta, fala, permanece, obedece, reduz estereotipias, tolera frustrações, executa comandos. Tudo isso pode ter alguma importância, dependendo do caso. Mas o problema é quando essas medidas passam a ocupar o lugar da criança inteira.

O que o sistema mostra

- A meta, mas nem sempre o custo subjetivo
- A evolução, mas nem sempre a exaustão
- O ganho de habilidade, mas nem sempre a perda de espontaneidade
- A redução do comportamento, mas nem sempre o aumento do sofrimento silencioso
- O gráfico, mas nem sempre a mãe
- O protocolo, mas nem sempre a criança

O que costuma ser escondido

- As incertezas científicas e divergências entre pesquisadores
- As críticas feitas por adultos autistas
- Os conflitos econômicos e os limites dos estudos
- Os efeitos adversos das intervenções
- A diferença entre melhora comportamental e bem-estar

Quando uma família só recebe a parte mais favorável de uma informação, ela não está sendo informada. Está sendo conduzida. Informação verdadeira precisa incluir limites. Se uma terapia tem benefícios possíveis, a família deve saber — mas também deve saber para quem esses benefícios foram observados, em quais condições, com qual intensidade e com quais riscos. Se há controvérsias, a família deve saber. Se há estudos frágeis, a família deve saber. Se há críticas de autistas adultos, a família deve saber. O cuidado ético exige transparência.

No Brasil, o Censo 2022 também mostrou diferenças por cor ou raça no diagnóstico informado de TEA. O maior percentual foi entre pessoas declaradas brancas, com **1,3%**, enquanto pessoas pretas e pardas apresentaram **1,1%** cada. O IBGE também registrou diferenças importantes na escolarização e no acesso educacional. Essas diferenças lembram que diagnóstico também depende de acesso: quem chega ao serviço? Quem consegue laudo? Quem tem plano? Quem consegue pagar avaliação? Quem é reconhecido mais cedo? Quem permanece invisível? Por isso, falar em autismo não é falar apenas de cérebro, comportamento ou genética. É falar também de classe social, raça, escola, território, acesso, mercado e política pública. O sistema mostra a criança diagnosticada. Mas muitas vezes esconde as condições sociais que tornam alguns diagnósticos mais visíveis do que outros.

A Família entre a Culpa e a Obediência

O discurso dominante sobre o autismo frequentemente coloca a família em uma posição impossível. Se aceita tudo, pode sobrecarregar a criança e a si mesma. Se questiona, é acusada de negligência. Se pede tempo, é alertada de que está perdendo uma janela preciosa. Se procura outras leituras, escuta que está fugindo da ciência. Se percebe sofrimento na criança, escuta que precisa insistir. Se não consegue pagar, sente culpa. Se não consegue manter a rotina terapêutica, sente fracasso.

Esse mecanismo é especialmente cruel com as mães. Muitas passam a viver como gestoras do tratamento do filho: organizam agenda, transportes, relatórios, pagamentos, escola, alimentação, crises, sono, consultas, terapias, reuniões — e ainda precisam lidar com a própria angústia. Mas, ao mesmo tempo, raramente são escutadas como sujeitos. São orientadas, corrigidas, treinadas, cobradas, ensinadas e avaliadas. O sistema exige que a mãe seja parceira da intervenção, mas nem sempre reconhece seu sofrimento.

A dívida infinita

Quando algo não melhora, a culpa pode voltar para a família: não estimulou o suficiente, não aplicou em casa, não manteve a rotina, não generalizou a aprendizagem, não fez as horas necessárias, não teve constância. Desse modo, o discurso terapêutico pode produzir uma espécie de dívida infinita. A família nunca fez o bastante. A mãe nunca descansou sem culpa. A criança nunca correspondeu totalmente ao ideal esperado. Essa lógica precisa ser interrompida.

Prevalência por faixa etária

O IBGE mostrou que a prevalência de diagnóstico foi maior entre os mais jovens: **2,1%** de 0 a 4 anos, **2,6%** de 5 a 9 anos, **1,9%** de 10 a 14 anos e **1,3%** de 15 a 19 anos. Esses números mostram que muitas famílias estão enfrentando o diagnóstico justamente nos anos mais intensos da infância. Por isso, não basta dizer que a criança precisa de intervenção. Também é preciso perguntar: quem cuida de quem cuida?

Uma mãe esgotada não precisa de mais culpa. Precisa de escuta, apoio, informação honesta e liberdade para pensar.

Recuperar o Direito de Perguntar

Este capítulo começou com uma cena: uma mãe recebe o diagnóstico do filho e, junto com ele, uma avalanche de recomendações. O que chega às famílias não é apenas conhecimento. É conhecimento organizado por um sistema que seleciona palavras, destaca evidências, promove métodos, constrói autoridades, cria urgências, oferece promessas e define quais perguntas parecem legítimas. Esse sistema não é totalmente falso — pode produzir cuidados importantes, abrir direitos e orientar intervenções. Mas se torna perigoso quando se apresenta como única verdade possível.

> Perguntar não é negar o diagnóstico. Perguntar não é rejeitar a ciência. Perguntar não é abandonar a criança. Perguntar é justamente uma forma de cuidado.

01

Quem está recomendando?

Com base em quais estudos? Esses estudos avaliaram crianças parecidas com meu filho?

02

O que foi medido como melhora?

Houve avaliação de sofrimento? Quais são os riscos? Quantas horas estão sendo propostas?

03

Existe espaço para brincar e descansar?

O que acontece se a criança recusar? A intervenção busca ajudar meu filho ou normalizá-lo?

04

O plano pode ser revisto?

Essas perguntas não atrapalham o tratamento. Elas protegem a criança. Os dados mostram que o autismo é hoje um fenômeno social de grande escala: no Brasil, são **2,4 milhões de pessoas diagnosticadas com TEA**; nos Estados Unidos, o CDC estima que **1 em cada 31 crianças de 8 anos** foi identificada com TEA. Diante de números tão expressivos, não podemos aceitar respostas simplistas.

Quanto maior o campo, maior deve ser a responsabilidade ética. Quanto maior o mercado, maior deve ser a transparência. Quanto maior a autoridade de um discurso, maior deve ser o direito de interrogá-lo. A criança autista não pode ser reduzida a uma disputa entre métodos. Ela não é propriedade da medicina, da pedagogia, da psicologia, da psicanálise, da terapia ocupacional, da fonoaudiologia, da escola, da clínica ou do mercado. Ela é um sujeito. E todo sujeito merece mais do que protocolo. Merece cuidado, escuta, proteção, tempo e respeito por sua forma singular de existir. Este é o ponto de partida deste livro: **devolver às famílias o direito de pensar antes de obedecer**.

Capítulo 2

Quando o Diagnóstico Vira Território de Disputa

Quando uma família recebe o diagnóstico de autismo, ela não recebe apenas uma explicação. Recebe também uma lista de decisões: que terapia fazer, quantas vezes por semana, o que pedir à escola, o que exigir do plano de saúde. De repente, a família precisa entender termos médicos, terapêuticos, escolares e jurídicos.

O diagnóstico abre portas importantes — pode garantir direitos, ajudar a criança a receber apoio, orientar a escola, permitir acesso a terapias. Mas também coloca a família dentro de um campo de disputa, com muitos profissionais falando, muitas clínicas oferecendo tratamento, muitas páginas prometendo orientação. É nesse momento que surge o risco: quando o diagnóstico deixa de servir à criança e passa a servir a um sistema de interesses.

No Brasil, o Censo 2022 identificou **2,4 milhões de pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista**, correspondendo a **1,2% da população brasileira**. Foi a primeira vez que o Censo investigou diretamente a população com diagnóstico de TEA. Esse dado mostra que o autismo se tornou uma questão de grande impacto social, familiar, escolar, clínico e econômico. O crescimento dos diagnósticos exige mais cuidado, mais políticas públicas e mais informação — mas também exige mais atenção. Onde há muitas famílias buscando ajuda, também pode haver muita gente vendendo soluções rápidas.



Por que os Diagnósticos Aumentaram?

O aumento dos diagnósticos não significa, necessariamente, que "nasceram muito mais autistas" do que antes. Vários fatores explicam esse crescimento: mais informação sobre autismo, mais profissionais treinados para identificar sinais precoces, escolas que encaminham mais crianças para avaliação, famílias que procuram mais ajuda, e critérios diagnósticos que mudaram ao longo do tempo. Crianças que antes recebiam outros nomes ou nenhum diagnóstico agora podem ser identificadas como autistas.

Além disso, o diagnóstico passou a ser necessário para acessar muitos direitos. Sem laudo, muitas famílias não conseguem acompanhante escolar, terapias, adaptações, benefícios ou cobertura pelo plano de saúde. Por isso, o diagnóstico também virou uma espécie de senha — ele abre caminhos, mas também organiza a vida da criança em torno de documentos, relatórios e exigências.

1,2%

Prevalência no Brasil

2,4 milhões de pessoas com TEA identificadas no Censo 2022 — primeira investigação direta do Censo sobre autismo

3,2%

Prevalência nos EUA

Cerca de 1 em cada 31 crianças de 8 anos identificadas com TEA, segundo estimativa mais recente do CDC

1 em 150

Estimativa em 2000

Prevalência nos EUA no ano 2000, mostrando a trajetória de crescimento dos diagnósticos nas últimas décadas

Um número grande não explica tudo. Ele não diz, sozinho, qual tratamento é melhor, que toda criança precisa da mesma intervenção, ou que existe um único caminho. O aumento dos diagnósticos deve levar a uma pergunta mais cuidadosa: **como garantir apoio sem transformar todas as crianças em clientes de um mercado terapêutico?**

O Diagnóstico como Porta de Entrada para Serviços

O alívio do nome

Para muitas famílias, o diagnóstico é um alívio. Finalmente existe um nome para aquilo que antes parecia confuso. A criança não é "malcriada", "preguiçosa", "sem limite", "estranha" ou "difícil porque quer". O diagnóstico pode ajudar a família a compreender melhor a criança, reduzir julgamentos e abrir acesso a direitos.

A nova pressão

Depois do diagnóstico, a família passa a receber muitas recomendações: neuropediatra, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicoterapia, ABA, psicopedagogia, integração sensorial, acompanhante terapêutico, mediação escolar, relatórios, avaliações, reavaliações. Algumas dessas ajudas podem ser importantes — o problema não é buscar apoio.

O problema é quando a família começa a sentir que precisa preencher toda a semana da criança com intervenções. A infância vira agenda. A criança vai da escola para a terapia, da terapia para outra terapia, de uma avaliação para outro relatório, de uma meta para outra meta.

Muitas vezes, ninguém pergunta se aquela criança está exausta, se tem tempo de brincar, se suporta aquele ritmo, se o tratamento está ajudando ou apenas treinando a criança a parecer mais adequada. O diagnóstico deveria abrir possibilidades. Mas, em muitos casos, ele abre uma corrida. E uma corrida não é o melhor modo de cuidar de uma criança.

Quando o Diagnóstico Movimenta Dinheiro

Todo campo de cuidado também movimenta dinheiro. Isso não significa que todo profissional age por interesse financeiro — muitos profissionais trabalham com seriedade, ética e dedicação. Mas é preciso reconhecer que o autismo também se tornou um grande mercado.

O mercado do autismo

Clínicas especializadas, cursos de formação, supervisões, certificações, materiais pedagógicos, aplicativos, planilhas, protocolos, consultorias, laudos, avaliações, pacotes terapêuticos, processos judiciais, serviços para escolas, famílias e planos de saúde.

O problema

O problema aparece quando o mercado começa a falar em nome da ciência. Uma clínica pode vender um pacote de muitas horas semanais dizendo que aquilo é "o único caminho com evidência". Um curso pode formar profissionais rapidamente prometendo alta demanda de trabalho. Um serviço pode usar o medo da família para justificar tratamentos caros e intensivos. Um plano de saúde pode negar atendimento alegando critérios administrativos.

A família no meio

De um lado, profissionais e clínicas dizendo que é preciso fazer muito. Do outro, planos de saúde tentando limitar custos. No centro, a criança. E, quase sempre, uma mãe tentando resolver tudo.

> É por isso que precisamos diferenciar cuidado de mercado. **Cuidado pergunta: o que essa criança precisa? Mercado pergunta: que serviço pode ser vendido?** Essas duas perguntas nem sempre levam ao mesmo lugar.

A Força da Palavra "Evidência"

Hoje, muitas famílias escutam que devem escolher apenas terapias "baseadas em evidências". Em princípio, isso parece correto — ninguém quer oferecer à criança algo sem fundamento, perder tempo com promessas vazias ou ser enganado. O problema está no uso simplificado da palavra "evidência".

Nem toda evidência tem a mesma força

Há estudos grandes e estudos pequenos. Há pesquisas bem controladas e pesquisas frágeis. Há resultados de curto prazo e poucos dados de longo prazo. Há estudos que medem comportamento, mas não medem sofrimento. Há estudos que mostram ganho em uma escala, mas não mostram como a criança viveu aquela intervenção.

Por isso, dizer que uma terapia "tem evidência" não basta. A família precisa saber: que tipo de evidência? Quantos estudos? Com quantas crianças? Por quanto tempo? Com quais resultados? Com quais riscos? Quem financiou? O que ficou de fora? A palavra "evidência" deve abrir perguntas, não encerrar a conversa. Quando alguém diz "a ciência já provou", a família tem o direito de perguntar: **provou exatamente o quê?**

O que fica de fora

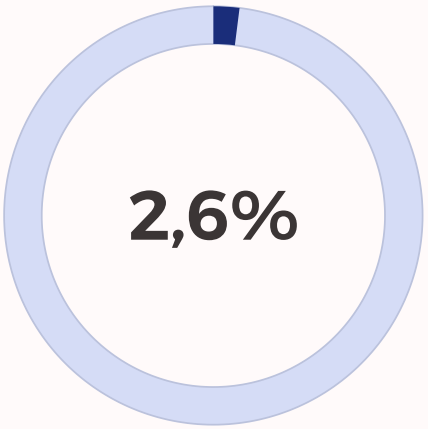
Muitas intervenções no autismo medem principalmente comportamentos visíveis. Mas uma criança não é apenas comportamento. Ela também sente medo, cansa, recusa, sofre, se protege, inventa saídas, tem preferências e tem limites.

Se a ciência mede apenas o que aparece por fora, pode deixar de fora aquilo que mais importa por dentro.

A Promessa da Intervenção Precoce

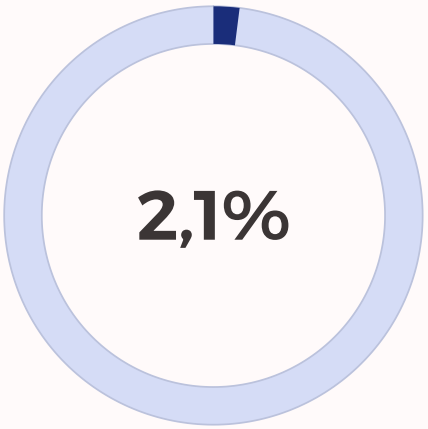
A intervenção precoce é uma das expressões mais repetidas no campo do autismo. Ela parte de uma ideia importante: quanto mais cedo uma criança recebe apoio adequado, maiores podem ser as chances de desenvolvimento. Essa ideia tem valor. O problema é quando ela é transformada em pressão.

Muitas famílias escutam que precisam começar imediatamente. Que cada semana perdida é um prejuízo. Que a criança precisa de muitas horas. Que não há tempo para pensar. Que descansar é perder oportunidade. Assim, a intervenção precoce pode virar urgência permanente — e a urgência permanente pode impedir uma decisão cuidadosa. A família assustada aceita mais facilmente qualquer proposta: muitas horas, custos altos, métodos que não compreende bem, metas que talvez não façam sentido para aquela criança.



Crianças de 5 a 9 anos

Maior prevalência de diagnóstico de TEA no Brasil segundo o Censo 2022, mostrando que muitas famílias recebem diagnósticos nos primeiros anos da infância



Crianças de 0 a 4 anos

Alta prevalência também nessa faixa etária, reforçando a importância do cuidado precoce no início da vida

É claro que a criança precisa de apoio. Mas apoio não é sinônimo de excesso. Uma criança pequena também precisa de descanso, de vínculo, de previsibilidade, de brincadeira, de tempo livre, de uma família menos desesperada. Cuidado precoce não deve significar captura precoce da criança por um sistema de treinamentos. A pergunta correta não é apenas "começou cedo?" — a pergunta também deve ser: **começou de forma respeitosa?**

Nem Toda Criança Precisa do Mesmo Caminho

O autismo é chamado de espectro porque não se apresenta do mesmo modo em todas as pessoas. Há crianças que falam bastante e crianças que não usam fala oral. Há crianças com deficiência intelectual assoOs manuais diagnósticos costumam falar em “espectro autista” para reunir, sob uma mesma categoria, crianças e adultos muito diferentes entre si.

Mas é preciso ter cuidado.

Do ponto de vista da psicanálise, uma criança não deve ser pensada apenas a partir de uma classificação. O diagnóstico pode até ter valor administrativo, escolar ou jurídico. Pode abrir direitos. Pode orientar alguns encaminhamentos. Mas ele não diz tudo sobre aquela criança.

O nome “autismo” não explica, sozinho, como uma criança sofre, como se defende, como se comunica, como se relaciona com o corpo, como responde à voz, ao olhar, à presença do outro, aos objetos, às palavras e às exigências do mundo.

Mesmo assim, muitas vezes as famílias recebem recomendações muito parecidas, como se o diagnóstico bastasse para definir o tratamento. Mas diagnóstico não é destino terapêutico. Duas crianças com o mesmo diagnóstico podem precisar de coisas muito diferentes.



Comunicação alternativa

Uma criança pode precisar de recursos para se expressar de formas não-verbais



Apoio escolar

Outra pode precisar de adaptação curricular, estratégias de inclusão e recursos de acessibilidade



Menos estímulos

Outra pode precisar de ambientes mais silenciosos, previsíveis e com menos sobrecarga sensorial



Acompanhamento familiar

Outra pode precisar de suporte à família, que consiga sustentar o cuidado no cotidiano

O risco do sistema hegemônico é tratar a criança a partir do nome do transtorno, e não a partir de sua vida concreta. A pergunta não deve ser apenas "qual é o diagnóstico?" — a pergunta deve ser: quem é essa criança? Como ela se comunica? Do que ela sofre? O que a acalma? O que a desorganiza? Como ela brinca? Como ela recusa? Como ela pede ajuda? O que a família consegue sustentar? Sem essas perguntas, o tratamento vira aplicação de modelo. E criança nenhuma deveria ser reduzida a um modelo.

A Escola no Centro da Disputa

O laudo como chave de acesso

A escola é um dos lugares onde o diagnóstico mais produz efeitos. Muitas famílias só conseguem apoio escolar depois do laudo. A partir dele, podem solicitar adaptações, acompanhamento, recursos de acessibilidade e estratégias de inclusão. Isso é importante.

Mas também pode gerar conflito. Algumas escolas não sabem como lidar com crianças autistas. Outras aceitam a matrícula, mas não oferecem inclusão real. Outras exigem que a criança se adapte completamente à rotina, sem adaptar o ambiente. Outras colocam toda a responsabilidade sobre a família ou sobre o acompanhante. A inclusão, nesses casos, vira apenas presença física. A criança está na escola, mas não necessariamente pertence à escola.

O que os números mostram

Segundo o Censo 2022, havia **760,8 mil estudantes de 6 anos ou mais** com diagnóstico de TEA no Brasil, representando **1,7% dos estudantes** nessa faixa. A maior parte estava no ensino fundamental regular: **508 mil estudantes**, ou **66,8% dos estudantes com autismo**.

Esse número mostra a importância da escola na vida das crianças autistas — mas também mostra o tamanho do desafio. Não basta colocar a criança na sala. É preciso pensar: como ela participa? Como ela aprende? Como ela descansa? Como ela se comunica? Como os colegas são orientados? Como os professores são apoiados? Como a escola adapta o ambiente? Como evita transformar inclusão em treinamento de obediência?

A escola não deve ser apenas o lugar onde a criança aprende a parecer igual. Ela deve ser o lugar onde a criança encontra condições para existir com os outros.

O Perigo das Soluções Prontas

Famílias cansadas querem respostas. Isso é compreensível. Quando uma mãe não dorme, quando a criança está em crise, quando a escola cobra, quando o plano nega, quando a família critica, quando tudo parece urgente, qualquer promessa de solução parece um alívio. É nesse momento que as soluções prontas se tornam perigosas.

Frases que parecem fortes, mas são simplificações

- "Esse é o único método comprovado."
- "Faça isso e seu filho vai evoluir."
- "Sem essa terapia, ele ficará para trás."
- "Quanto mais horas, melhor."
- "Não questione, confie na ciência."

O que uma boa proposta de cuidado deve fazer

Nenhuma terapia deveria prometer o que não pode garantir. Nenhuma família deveria ser convencida pelo medo. Nenhuma criança deveria ser submetida a um plano que não pode ser revisto. Uma boa proposta de cuidado precisa reconhecer limites: deve explicar o que pretende fazer, dizer quais resultados espera, admitir o que não sabe, observar a resposta da criança, escutar a família, aceitar mudanças de rota e respeitar sinais de sofrimento.

> Quando uma intervenção não aceita pergunta, ela deixa de ser cuidado e se aproxima de doutrina. Quando uma clínica não admite limites, ela não está fazendo ciência — está vendendo certeza. E certezas absolutas são perigosas, principalmente quando envolvem crianças. **O cuidado verdadeiro não começa com promessa. Começa com escuta.**

O Diagnóstico Deve Abrir Direitos, Não Aprisionar a Criança

O diagnóstico de autismo pode ser muito importante. Ele pode nomear dificuldades reais, abrir acesso a direitos, orientar a escola, ajudar a família, permitir apoios necessários e proteger a criança de julgamentos injustos. Mas ele não deve aprisionar a criança em uma única narrativa.

A criança além do laudo

A criança autista não é apenas um laudo. Não é apenas uma escala. Não é apenas um nível de suporte. Não é apenas uma lista de déficits. Não é apenas uma meta terapêutica. Ela é uma pessoa em desenvolvimento, com sua forma própria de perceber, sentir, comunicar, recusar, brincar, aprender e se relacionar.

O território de disputa

Este capítulo mostrou que o diagnóstico virou um território de disputa: entre cuidado e mercado, entre ciência e propaganda, entre direito e burocracia, entre escola inclusiva e escola adaptadora, entre apoio e excesso, entre tratamento e normalização.

Os números mostram a dimensão do desafio — **2,4 milhões de pessoas diagnosticadas com TEA** no Brasil; **1 em cada 31 crianças de 8 anos** identificadas com TEA nos EUA. Mas esses números não autorizam respostas únicas. Quanto maior o desafio, maior deve ser a responsabilidade.

Ampliar cuidado Não reduzir a criança a um protocolo	**Abrir possibilidades** Não impor medo
Garantir direitos Não criar obediência	**Ajudar a família** Não entregar a criança a um sistema que decide tudo por ela

> A pergunta final deste capítulo é simples: **o diagnóstico está servindo à criança ou a criança está sendo obrigada a servir ao diagnóstico?**

Capítulo 3

ABA: Quando a Ciência Vira Palavra de Ordem

Muitas mães escutam a mesma frase: **"ABA é o padrão-ouro para o autismo."** Ela parece encerrar a conversa. Se é "científica", questionar parece ignorância. Se é "baseada em evidências", duvidar parece irresponsabilidade. Mas a psicanálise começa justamente onde o discurso pronto tenta terminar.

A pergunta não é apenas "ABA funciona?" — a pergunta é mais profunda: **funciona para produzir o quê?** Produz mais obediência? Mais adaptação? Mais respostas esperadas? Ou produz mais possibilidade de laço, de invenção, de alívio e de existência para aquela criança?

Uma criança pode aprender a responder melhor a comandos e, ainda assim, continuar sofrendo. Pode reduzir um comportamento e, mesmo assim, perder uma forma própria de se proteger. Pode parecer mais adequada aos olhos dos adultos e, ao mesmo tempo, estar mais apagada subjetivamente. A psicanálise não começa pelo comportamento isolado — ela pergunta pela posição da criança, pela função daquele gesto, daquele silêncio, daquela recusa. Nem tudo que incomoda o adulto é um problema a eliminar. Às vezes, aquilo que aparece como comportamento inadequado é uma tentativa da criança de se defender de algo que a invade. Quando a clínica ignora isso, ela pode transformar cuidado em treinamento. E **treinamento não é o mesmo que tratamento.**

O Que É ABA em Linguagem Simples

A Lógica da ABA

ABA é a sigla para **Análise do Comportamento Aplicada**. Ela observa comportamentos, define metas e usa estratégias de reforço para aumentar alguns comportamentos e diminuir outros. A lógica central é: observar, medir, intervir e comparar resultados.

É por isso que a ABA costuma agradar a instituições, clínicas, escolas e planos de saúde: ela produz registros, gráficos, metas, relatórios e números.

O Que Fica de Fora?

A pergunta psicanalítica é outra: o que fica de fora quando uma criança é lida principalmente pelo comportamento? Fica de fora a **função daquele comportamento.**

- Uma criança que grita pode estar recusando uma invasão
- Uma criança que tapa os ouvidos pode estar se protegendo do excesso de som
- Uma criança que se balança pode estar tentando organizar o próprio corpo
- Uma criança que evita olhar pode estar se defendendo da presença invasiva do outro
- Uma criança que se apega a um objeto pode ter encontrado ali uma borda, um apoio, uma segurança

Se o tratamento olha apenas para o comportamento, pode tentar retirar justamente aquilo que a criança usa para se sustentar. Isso não significa que todo comportamento deva ser mantido — mas intervir não é apagar. Intervir exige perguntar antes: **qual é a função disso para essa criança?** Sem essa pergunta, o tratamento corre o risco de corrigir por fora e desorganizar por dentro.

A Promessa da Intervenção Intensiva

Uma das modalidades mais conhecidas ligadas à ABA é a **Intervenção Comportamental Intensiva Precoce (EIBI)**, geralmente indicada para crianças pequenas. A revisão Cochrane descreve a EIBI como uma intervenção baseada em ABA, geralmente oferecida por vários anos e com intensidade de **20 a 40 horas semanais**. Essa informação é muito importante para as famílias, porque mostra que não estamos falando apenas de uma consulta semanal — em muitos casos, estamos falando de uma reorganização profunda da infância da criança.

20 a 40 Horas

Semanais — quase uma jornada de trabalho para uma criança pequena. Isso precisa ser pensado com muito cuidado.

O Que Fica?

A criança tem tempo para brincar? Para descansar? Para não responder a demandas? Para ficar com a família sem estar sendo treinada? Para inventar algo próprio?

A Infância Importa

Do ponto de vista da psicanálise, o tempo da criança importa. A pausa importa. O brincar importa. A recusa importa. O silêncio importa. O objeto escolhido pela criança importa.

Uma intervenção intensiva pode até produzir ganhos em algumas áreas. Mas intensidade não é sinônimo automático de cuidado. Às vezes, o excesso de intervenção também pode ser uma forma de invasão. E aquilo que invade, mesmo quando vem em nome do bem, pode produzir sofrimento.

O Que a Cochrane Realmente Disse

Muitas famílias escutam que a ABA é totalmente comprovada. Mas quando olhamos para revisões científicas importantes, o cenário é mais cauteloso. A revisão Cochrane sobre EIBI encontrou apenas **cinco estudos relevantes**, envolvendo ao todo **219 crianças**. Destas, **116** estavam nos grupos que receberam EIBI e **103** nos grupos de comparação. Apenas **um estudo** tinha desenho considerado ideal, com distribuição aleatória das crianças entre os grupos. Os outros estudos usaram formas menos fortes de comparação.

5

Estudos Relevantes

Encontrados pela revisão Cochrane sobre EIBI

219

Crianças no Total

116 no grupo EIBI e 103 nos grupos de comparação

1

Estudo com Delineamento Ideal

Apenas um estudo teve distribuição aleatória entre os grupos

A própria Cochrane afirma que a evidência apoia o uso da EIBI para algumas crianças, mas que os resultados devem ser interpretados com cautela, porque a qualidade da evidência é fraca, há poucos participantes e apenas um estudo teve desenho ótimo. A Cochrane **não disse** que toda criança autista deve fazer ABA, **não disse** que ABA é obrigatória, **não disse** que quanto mais horas, melhor para todos. O que ela disse foi muito mais limitado: encontrou evidências fracas de melhora em algumas áreas, como comportamento adaptativo, inteligência e linguagem, após cerca de dois anos de tratamento. Mas não encontrou diferenças para gravidade dos sintomas de autismo nem para comportamento-problema.

⚠ Além disso, nenhum dos estudos relatou eventos adversos — o que não significa necessariamente que eles não existiram. Significa que não foram relatados nesses estudos. Ausência de relato de dano não é a mesma coisa que prova de ausência de dano. Se os estudos não medem sofrimento, exaustão, angústia, retraimento ou apagamento subjetivo, esses efeitos podem ficar invisíveis. E aquilo que não é medido pode desaparecer do discurso científico.

O Problema do "Padrão-Ouro"

A expressão "padrão-ouro" é muito poderosa. Ela dá a impressão de que existe uma terapia superior, indiscutível e universal. Mas no campo do autismo essa expressão precisa ser interrogada. Primeiro, porque o próprio autismo, enquanto categoria, reúne crianças muito diferentes entre si. Mesmo usando a linguagem dos manuais, trata-se de uma categoria ampla. Do ponto de vista da psicanálise, essa amplitude exige ainda mais cuidado: o nome diagnóstico não diz como cada criança se defende, se comunica, sofre ou inventa seu modo de estar no mundo.

Evidência Limitada ≠ Promessa Absoluta

Ter alguns estudos favoráveis não é o mesmo que ter uma resposta universal. Ter melhora em escalas não é o mesmo que garantir melhora subjetiva. Ter resultado em grupo não é o mesmo que saber o que acontecerá com uma criança singular. Ter gráfico não é o mesmo que ter clínica.

O Discurso Apaga Diferenças

O discurso do "padrão-ouro" transforma uma pergunta clínica em uma ordem: "faça ABA." Mas a clínica não pode começar por uma ordem — a clínica começa por uma escuta. Para a psicanálise, o ponto de partida é a singularidade da criança.

Alerta Necessário

Quando uma terapia se apresenta como única saída, a família deve acender um alerta. Na ciência séria, todo método tem limite. Na clínica ética, toda intervenção deve poder ser questionada. No cuidado verdadeiro, nenhuma criança deve ser forçada a caber em um ideal de normalidade.

Comportamento Não É Tudo

A ABA trabalha principalmente com comportamento observável — isso é uma escolha de método. Ela observa o que a criança faz, registra frequência, define metas e mede mudanças. Mas, para a psicanálise, o comportamento não é o ponto final. Ele é um sinal. Algo aparece no corpo, no gesto, na repetição, na recusa, na fala ou no silêncio. Esse algo precisa ser lido, não apenas corrigido.

O Que a Recusa Pode Dizer

Uma criança que se recusa a entrar em uma sala pode estar dizendo algo. Talvez aquela sala tenha muito barulho. Talvez a presença do adulto seja invasiva. Talvez a atividade seja vivida como exigência insuportável. Talvez a criança não consiga antecipar o que vai acontecer. Talvez a recusa seja a única forma encontrada para se proteger. Se a recusa é tratada apenas como comportamento inadequado, perde-se a chance de entender sua função.

O mesmo vale para movimentos repetitivos, apego a objetos, ecolalias, isolamento e crises. Aquilo que parece estranho para o outro pode ter uma função de organização para a criança.

A Diferença Fundamental

A psicanálise não trabalha para arrancar rapidamente uma manifestação. Ela busca construir condições para que a criança encontre outros modos de se ligar ao mundo, sem ser violentada em sua defesa.

A questão não é deixar a criança abandonada em seu sofrimento. A questão é **não confundir sofrimento da criança com incômodo do adulto.**

- Nem toda diferença é déficit
- Nem toda repetição é atraso
- Nem toda recusa é oposição

Às vezes, a recusa é uma resposta muito séria diante de uma demanda vivida como invasiva. Escutar isso muda completamente a direção do cuidado.

Quando a Melhora Pode Esconder Sofrimento

Como saber se uma criança melhorou de verdade? Um relatório pode mostrar que a criança passou a obedecer mais comandos — mas ela está mais tranquila? Um gráfico pode mostrar redução de crises — mas ela está mais viva ou mais apagada? A psicanálise ajuda a fazer uma diferença fundamental: **adaptação não é necessariamente cuidado.**

O Que os Relatórios Mostram

Mais obediência, menos crises, mais habilidades em escalas, mais contato visual.

O Que Pode Acontecer por Dentro

A criança pode ficar mais adaptada ao desejo dos adultos e, ainda assim, mais distante de si mesma. Pode aprender a responder certo, mas perder a possibilidade de recusar. Pode aprender a parecer menos autista, mas ficar mais angustiada.

Essa é uma das críticas feitas por muitos adultos autistas a intervenções muito normalizadoras. Eles apontam que certas práticas podem ensinar a criança a mascarar sinais, suportar invasões e corresponder a expectativas externas, sem que seu sofrimento seja realmente considerado. O estudo de **Henny Kupferstein**, publicado em 2018, investigou relatos de sintomas de estresse pós-traumático em pessoas expostas à ABA. O estudo trabalhou com **460 respondentes** e relatou associação entre exposição à ABA e sintomas de TEPT.

Esse dado deve ser usado com prudência: o estudo tem limites metodológicos e não prova causalidade direta. Ainda assim, ele é importante como sinal de alerta: o sofrimento produzido por intervenções também precisa ser pesquisado e escutado. A questão não é usar esse estudo como prova definitiva contra toda ABA. A questão é outra: por que os efeitos negativos são tão pouco discutidos com as famílias? Quando uma criança começa a dormir pior, se retrair, se apagar, ficar mais irritada, perder espontaneidade ou demonstrar medo intenso, isso não deve ser tratado automaticamente como resistência ao tratamento — pode ser o próprio tratamento produzindo sofrimento.

O Mercado da ABA

A ABA não é apenas uma técnica. Ela também se tornou um **grande mercado**. Há clínicas especializadas, cursos, certificações, supervisões, materiais, planilhas, softwares, consultorias, relatórios, treinamentos parentais e disputas por cobertura em planos de saúde. Isso não significa que todo profissional de ABA age de má-fé — seria injusto dizer isso. Muitos profissionais são sérios e realmente desejam ajudar. Mas não se pode ignorar que existe um campo econômico em torno da ABA.

$452M

Gasto Total em 2021

Em serviços de ABA no programa TRICARE nos EUA (ano fiscal de 2021)

16.657

Beneficiários

Participantes que haviam apresentado pedidos de reembolso por serviços de ABA

2028

Autorização Vigente

O programa TRICARE Autism Care Demonstration está autorizado até 31 de dezembro de 2028

Esses números mostram que não estamos falando apenas de uma discussão clínica. Estamos falando de um setor que movimenta muito dinheiro. E onde há muito dinheiro, é necessária mais transparência. A família precisa saber quando uma recomendação é clínica e quando também é comercial. Precisa saber quem ganha com muitas horas de terapia, com cursos, com laudos, com judicialização, com pacotes fechados, com a ideia de que só existe uma terapia legítima. Cuidado e mercado podem se misturar.

> A pergunta ética é indispensável: **a indicação está sendo feita porque essa criança precisa ou porque esse sistema precisa vender?**

O Que Perguntar Antes de Aceitar uma Proposta

Uma família não precisa aceitar uma proposta terapêutica apenas porque ela vem acompanhada da palavra "ciência". A família tem o direito de perguntar. E bons profissionais não deveriam temer perguntas. Antes de aceitar um plano baseado em ABA ou em qualquer outra abordagem, a família pode perguntar:

Sobre os Objetivos

O objetivo é ajudar a criança ou fazê-la parecer menos autista? Quantas horas estão sendo propostas? Por que essa quantidade? Com base em quais estudos? Esses estudos são fortes ou limitados?

Sobre o Sofrimento

Como vocês avaliam sofrimento? O que acontece se a criança recusar? A recusa será escutada ou quebrada? A criança terá tempo de brincar livremente? Os interesses e objetos importantes para ela serão respeitados ou retirados?

Sobre a Família

Como a família participa sem ser culpabilizada? Quais sinais indicam que devemos diminuir, mudar ou interromper o tratamento? Existe espaço para rever o plano?

Essas perguntas não são ataques — são proteção. Uma intervenção séria deve conseguir explicar seus objetivos, seus limites e seus critérios de revisão. Se o profissional responde com ameaça, culpa ou arrogância, isso já diz muito. A família também precisa observar a criança: ela está mais tranquila? Está mais conectada à sua maneira? Está mais segura? Está menos invadida? Está encontrando formas de comunicar algo próprio? Está mais viva? Ou está apenas mais obediente?

Na psicanálise, o cuidado não é medido apenas pela adequação ao olhar do outro. Ele é pensado a partir da possibilidade de o sujeito encontrar uma forma menos sofrida de existir. Essa é uma diferença decisiva.

A Criança Não É um Projeto de Normalização

A discussão sobre ABA não deve ser reduzida a uma briga entre "contra" e "a favor". Essa divisão é pobre. A pergunta mais importante não é se uma técnica pode produzir algum efeito — a pergunta é: **qual é o preço subjetivo desse efeito?**

Clínica da Correção

Tenta ajustar a criança ao mundo. Pergunta: "como reduzir esse comportamento?" Busca normalizar, apagar diferenças, quebrar recusas, aumentar obediência e adaptar a criança ao ideal dos adultos.

Clínica do Sujeito

Tenta construir, com a criança, uma forma possível de habitar o mundo. Pergunta: o que esse comportamento sustenta? O que essa criança tenta evitar? Que recurso ela encontrou? Como ampliar suas possibilidades sem destruir sua defesa?

A criança autista não é um projeto de normalização. Ela não existe para parecer menos incômoda. Ela não existe para satisfazer a escola, a clínica, a família ou o mercado. Ela existe como sujeito. E sujeito não se treina como máquina. Do ponto de vista da psicanálise, a direção do cuidado deve partir da singularidade — acompanhar a criança em suas invenções, seus objetos, suas bordas, seus modos de defesa e suas tentativas de laço.

> Este capítulo não termina dizendo que toda ABA é igual, nem que toda família deve recusá-la. Ele termina com uma advertência: nenhuma terapia deve ocupar o lugar da verdade absoluta. Nenhum método deve calar a escuta da criança. Nenhum gráfico deve valer mais do que o sofrimento percebido pela família. Nenhuma promessa de evolução deve justificar a perda da singularidade. **Cuidar não é normalizar. Cuidar é sustentar a possibilidade de uma vida menos invadida, menos angustiada e mais própria.**

Capítulo 4

O Que o Discurso Dominante Esconde das Mães

Muitas mães recebem relatórios dizendo que o filho "melhorou" — sentou por mais tempo, olhou mais, obedeceu mais comandos, reduziu crises, repetiu palavras. Esses dados podem ter importância, mas não dizem tudo. A pergunta fundamental é: **essa criança está melhor ou apenas mais adaptada ao que os adultos esperam dela?**

Uma criança pode parecer mais calma porque aprendeu a se calar. Pode parecer mais obediente porque perdeu a possibilidade de recusar. Pode parecer mais funcional porque está escondendo sofrimento. Pode parecer menos autista porque está sendo treinada a apagar sinais de sua diferença.

Do ponto de vista da psicanálise, o comportamento visível nunca é suficiente para compreender uma criança. O comportamento é uma manifestação — pode ser uma defesa, uma tentativa de comunicação, uma resposta ao excesso, um modo de organizar o corpo ou de se proteger do outro. Quando o discurso dominante olha apenas para o que pode ser medido, ele esconde aquilo que não cabe facilmente em gráficos: a angústia, o cansaço, a invasão, a recusa, a singularidade, o sofrimento silencioso.

Por isso, uma mãe precisa confiar também no que percebe. Se ela sente que a criança está mais apagada, mais irritada, mais assustada ou menos espontânea, isso precisa ser levado a sério. **Nenhum gráfico deve valer mais do que os sinais de sofrimento de uma criança.**

O Que Não Cabe na Planilha

O que a planilha mostra

- Frequência de respostas
- Metas atingidas
- Porcentagens de evolução
- Redução de comportamentos
- Respostas corretas

O que a planilha esconde

- Se a criança **desejou** responder ao comando
- Se a atividade foi vivida como **invasão**
- Se o olhar foi **laço ou submissão**
- Se perdeu uma forma de **expressar sofrimento**
- Se perdeu uma forma importante de **se organizar**

A psicanálise não despreza o que aparece no comportamento, mas pergunta o que esse comportamento sustenta. Uma estereotipia pode ser uma tentativa de borda. Um objeto pode ser apoio. Uma repetição pode ser organização. Um silêncio pode ser proteção. Uma recusa pode ser defesa. Uma crise pode ser resposta a uma invasão insuportável. O que o discurso dominante esconde é justamente isso: muitas manifestações da criança não são simples defeitos a corrigir — às vezes, são **soluções encontradas por ela**.

Soluções frágeis. Soluções estranhas aos olhos dos outros. Soluções difíceis para a família. Mas ainda assim, soluções. Se retiramos uma solução sem construir outra, podemos deixar a criança mais desamparada. Por isso, antes de eliminar um comportamento, é preciso perguntar: **para que ele serve nessa criança?**

A Mãe Percebe Antes do Relatório

Muitas mães percebem coisas que os relatórios não registram: o filho dormindo pior, mais irritado depois da terapia, retraído quando determinado profissional chega, parou de brincar como antes, está mais obediente mas menos vivo. Algo mudou, mesmo quando os números dizem que houve progresso.

O que a mãe escuta quando questiona

"É resistência." "É fuga de demanda." "É manipulação." "É birra." "É falta de generalização em casa." "É porque a família não está aplicando corretamente." Assim, a mãe começa a duvidar de si mesma.

O saber da mãe

Ela conhece detalhes, ritmos, expressões, mudanças sutis, sinais de medo, formas de aproximação e afastamento, modos de sofrimento que ninguém mais percebe. Esse saber não pode ser apagado por nenhuma planilha.

O dado clínico que importa

Quando uma mãe diz "meu filho não está bem", isso precisa ser escutado — não como exagero, resistência, ignorância ou falta de adesão, mas como **dado clínico importante**.

O discurso dominante esconde das mães que elas também têm saber sobre seus filhos — não um saber técnico, mas um saber construído na convivência, no cuidado e na presença.

Nem Toda Recusa É Problema

A pergunta do discurso dominante

> "Como fazer essa criança aceitar?"

A criança não quer entrar na sala, não quer olhar, não quer tocar, não quer falar, não quer repetir, não quer sentar, não quer participar, não quer largar um objeto, não quer aceitar uma mudança.

A pergunta da psicanálise

> "O que essa recusa está dizendo?"

A recusa pode ser uma defesa importante. A criança pode estar dizendo que algo é demais — demais barulho, demais olhar, demais fala, demais toque, demais exigência, demais presença do outro, demais mudança.

Para algumas crianças autistas, o mundo pode chegar como invasão. A voz pode invadir. O olhar pode invadir. O toque pode invadir. A demanda pode invadir. A proximidade pode invadir. Nesses casos, a recusa não é simples oposição — é tentativa de proteção. Se o tratamento insiste em quebrar toda recusa, ele pode quebrar também uma defesa necessária.

Isso não quer dizer que a criança deve ficar isolada em seu sofrimento. Quer dizer que a aproximação precisa ser construída — com tempo, cuidado, delicadeza, leitura dos sinais, respeito ao limite e invenções pequenas. A clínica não deve esmagar a defesa da criança; deve ajudá-la a encontrar formas menos sofridas de estar com os outros. **Quando a recusa é escutada, ela pode se transformar em caminho. Quando é violentada, pode se transformar em trauma.**

O Corpo da Criança Também Fala

Muitas crianças autistas dizem com o corpo aquilo que não conseguem dizer com palavras. O corpo se agita, se fecha, corre, se joga, tapa os ouvidos, evita o olhar, se balança, se aproxima de certos objetos, rejeita certos sons, cheiros, texturas ou lugares. O discurso dominante muitas vezes tenta controlar esse corpo — fazer sentar, fazer olhar, fazer tocar, fazer responder, fazer tolerar, fazer permanecer, fazer imitar.



Se balançar

Pode ser uma tentativa de se regular.



Tampar os ouvidos

Pode ser uma forma de se proteger.



Correr

Pode ser tentar descarregar uma tensão insuportável.



Apegar-se a um objeto

Pode ser construir um apoio para suportar o mundo.

A psicanálise lembra que o corpo não é apenas organismo — é também lugar de marcas, de sensações, de invasões, de defesas e de modos singulares de satisfação e sofrimento. Se tratamos tudo isso apenas como comportamento inadequado, perdemos a clínica. O corpo da criança precisa ser **lido**, não domesticado. É claro que há situações em que é preciso intervir — se a criança se machuca, se coloca em risco ou coloca outros em risco, é necessário construir uma proteção. Mas proteger não é o mesmo que dominar.

A pergunta não deve ser apenas "como faço esse comportamento parar?" A pergunta deve ser: **o que esse corpo está tentando resolver?** Enquanto essa pergunta não aparece, o tratamento pode até produzir silêncio — mas silêncio não é necessariamente alívio.

A Criança Não Precisa Ser Treinada Para Parecer Normal

Grande parte do sofrimento das famílias nasce de uma expectativa silenciosa: a criança precisa parecer menos autista — olhar mais nos olhos, falar de forma mais comum, sentar como as outras, brincar como as outras, responder como as outras, cumprimentar como as outras, tolerar barulhos como as outras, participar da escola como as outras. Essa expectativa pode parecer natural, mas ela carrega um perigo.

Quando o objetivo é normalizar

- A diferença vira falha
- A defesa vira problema
- O objeto vira vício
- A repetição vira atraso
- O silêncio vira déficit
- A recusa vira desobediência

O que a psicanálise propõe

A psicanálise não parte da ideia de normalização — parte da ideia de **sujeito**. Isso muda tudo. O objetivo não é fazer a criança parecer igual às outras, mas ajudá-la a sofrer menos, construir laços possíveis, ampliar seus recursos e encontrar modos próprios de habitar o mundo.

Uma criança pode não olhar nos olhos e ainda assim estabelecer laço. Pode não falar oralmente e ainda assim comunicar. Pode repetir movimentos e ainda assim estar tentando organizar o corpo. Pode usar um objeto de modo estranho e ainda assim estar construindo uma borda importante. Pode brincar de maneira diferente e ainda assim estar inventando um modo de relação.

O discurso dominante esconde das mães que desenvolvimento não precisa significar apagamento da diferença. A criança não precisa ser treinada para parecer outra. **Ela precisa ser acompanhada para poder existir melhor como ela é.**

O Sofrimento da Mãe Também É Escondido

O discurso dominante fala muito sobre a criança, mas fala pouco sobre a mãe. Fala sobre adesão ao tratamento, rotina em casa, aplicar estratégias, estimular, reforçar, generalizar aprendizagens, seguir orientações. Mas quem escuta essa mãe? Quem escuta seu medo, sua culpa, seu cansaço, sua solidão, sua raiva, sua tristeza, sua sensação de fracasso, sua vida interrompida, seu corpo exausto?

O que dizem quando ela desaba

Que ela precisa ser forte.

O que dizem quando ela questiona

Que está atrapalhando.

O que dizem quando ela não consegue

Que precisa se organizar melhor.

O que dizem quando ela está cansada

Que é assim mesmo.

Muitas mães são transformadas em auxiliares do tratamento — recebem tarefas, orientações, cobranças e metas, mas raramente recebem escuta. Esse é um dos pontos mais cruéis do sistema: ele exige demais da mãe e escuta pouco o que isso produz nela.

Do ponto de vista da psicanálise, a mãe não é apenas cuidadora funcional — ela também é sujeito. Tem história, desejo, angústia, limites, perdas, fantasias, culpa e direito à palavra. Cuidar de uma criança autista não pode significar apagar a mãe. Quando a mãe é esmagada, toda a família sofre. O cuidado precisa incluir quem cuida, porque **uma mãe escutada pode respirar — e uma mãe que respira pode sustentar melhor a presença diante da criança.**

O Que os Autistas Adultos Tentam Dizer

Há algo que muitas famílias ainda escutam pouco: a voz dos próprios autistas. Durante muito tempo, médicos, terapeutas, pesquisadores, escolas, famílias e instituições falaram sobre autismo — mas os autistas foram muitas vezes colocados apenas como objeto de estudo e intervenção.

O que questionam

- Práticas que tentam apagar sinais autísticos
- Treinamentos que ensinam a mascarar sofrimento
- Intervenções baseadas em obediência
- A ideia de que parecer normal é sinônimo de estar bem
- Terapias que não respeitam recusa, sensibilidade e limites

O que o discurso dominante responde

- Que são casos isolados
- Que são pessoas "leves"
- Que não representam crianças com mais dificuldades
- Que não entendem a ciência

Essa desqualificação é perigosa.

É claro que uma criança autista não é igual a um adulto autista, e também é claro que nem todos os autistas pensam da mesma maneira. Mas quando muitas pessoas autistas dizem que certas práticas foram vividas como invasivas ou dolorosas, isso precisa produzir reflexão. A psicanálise nos lembra que a palavra do sujeito importa — mesmo quando ela incomoda, especialmente quando ela incomoda.

Escutar autistas adultos não significa transformar suas falas em regra universal. Significa reconhecer que **nenhuma discussão sobre autismo deveria acontecer sem levar em conta aqueles que vivem essa experiência no próprio corpo.**

O Que Deveria Ser Perguntado Antes de Qualquer Intervenção

Antes de iniciar qualquer tratamento, a família deveria receber perguntas mais humanas. Não apenas "qual é o diagnóstico? qual é o nível? qual é o déficit? qual é o comportamento-alvo? qual é a meta?" — mas perguntas que coloquem a criança como sujeito.

1

Quem é essa criança?

O que a angustia? O que a acalma? Como ela se protege? Como ela se aproxima e se afasta?

2

O que é importante para ela?

Que objetos, sons, lugares ou pessoas a invadem? Como ela demonstra sofrimento e interesse?

3

O que ela inventou para suportar o mundo?

O que precisa ser protegido antes de ser modificado? O que a família vive? O que a mãe percebe?

4

O que a escola não entendeu?

Essas perguntas mudam a direção do cuidado — impedem que a criança seja tratada como um conjunto de comportamentos.

Essas perguntas ajudam a perceber que, antes de corrigir, é preciso compreender. Antes de exigir, é preciso aproximar. Antes de retirar uma defesa, é preciso construir outra possibilidade. Antes de impor laço, é preciso tornar a presença do outro menos invasiva. A psicanálise propõe uma clínica delicada, que não confunde aproximação com invasão — uma clínica que respeita o tempo, acompanha pequenas invenções, valoriza objetos, interesses, repetições e circuitos quando eles servem como apoio, e ajuda a criança a construir caminhos possíveis sem esmagá-la em nome de uma norma.

> O discurso dominante esconde das mães que existem outras perguntas. E quem muda as perguntas, muda também o tratamento.

O Que Precisa Aparecer

Este capítulo mostrou que o discurso dominante não esconde tudo — ele mostra gráficos, metas, técnicas, protocolos, diagnósticos, relatórios, promessas e percentuais de evolução. Mas esconde aquilo que, muitas vezes, é mais importante: a função do comportamento, a defesa da criança, o sofrimento silencioso, o saber da mãe, a voz dos autistas, o corpo como lugar de experiência, a diferença entre adaptação e cuidado, entre obediência e laço, entre normalização e tratamento.

A criança antes do método	**A escuta antes da meta**	**O sujeito antes do comportamento**
O cuidado antes da normalização	**A singularidade antes do protocolo**	

A psicanálise não oferece uma fórmula pronta para todas as crianças — esse é justamente seu valor. Ela não começa pelo protocolo, começa pela escuta. Escutar uma criança autista é perguntar como ela se defende do excesso, como constrói bordas, como se apoia em objetos, como suporta ou evita o olhar e a voz do outro, como encontra pequenos caminhos para estar no mundo. Escutar uma mãe é reconhecer que ela também sabe algo, sofre algo e precisa de um lugar para falar. Escutar os autistas é admitir que nenhuma ciência deve ignorar aqueles sobre quem ela fala.

> Uma família bem informada não é aquela que apenas obedece ao discurso mais repetido. É aquela que pode perguntar, duvidar, observar, rever, proteger e escolher sem ser conduzida pelo medo.

O discurso dominante diz às mães: "faça isso, porque é o certo." Este livro propõe outra posição: **olhe para seu filho, escute os sinais, pergunte pelos limites, desconfie das promessas absolutas e nunca aceite que um método fale mais alto do que a criança.**

Capítulo 5

Como Decidir Sem Medo

Depois do diagnóstico, muitas famílias sentem que precisam decidir tudo rapidamente: qual terapia começar, quantas horas fazer, qual escola escolher, qual profissional procurar, qual laudo apresentar, qual direito exigir, qual orientação seguir. Tudo parece urgente — e, quando tudo parece urgente, pensar fica difícil. A mãe escuta muitas vozes ao mesmo tempo. Uma diz que precisa começar imediatamente. Outra diz que precisa fazer muitas horas. Outra diz que só existe uma terapia realmente científica. Outra diz que qualquer atraso pode prejudicar o futuro da criança.

Assim, a decisão deixa de ser livre e passa a ser tomada pelo medo. **Nenhuma família deveria decidir sob ameaça.** A criança autista precisa de cuidado, de apoio, de escola preparada, de profissionais responsáveis, de direitos garantidos — mas isso não significa aceitar qualquer proposta, qualquer método, qualquer carga horária ou qualquer promessa. Cuidar não é obedecer ao discurso mais forte. Cuidar é perguntar, observar, comparar, avaliar e rever.

Do ponto de vista da psicanálise, a criança não é apenas portadora de um diagnóstico. Ela é um sujeito. Tem uma forma própria de se defender, de se comunicar, de se aproximar, de recusar, de brincar e de habitar o mundo. Por isso, uma boa decisão não começa com a pergunta "qual método é o mais famoso?" — ela começa com outra pergunta: **o que essa criança precisa para sofrer menos e viver melhor?**

Nem Toda Ajuda Ajuda

Uma intervenção pode ter boa intenção e ainda assim ser invasiva. Pode ser bem organizada e ainda assim não servir para aquela criança. Pode ter relatórios bonitos e ainda assim produzir sofrimento. Pode ser famosa e ainda assim não respeitar a singularidade. Pode ser chamada de científica e ainda assim ser apresentada de forma exagerada, simplificada ou comercial. Isso não quer dizer que a família deva desconfiar de tudo — quer dizer que ela deve perguntar melhor.

Intenção vs. Efeito

Uma intervenção pode ter boa intenção e ainda assim ser invasiva ou produzir sofrimento. Antes de aceitar, é importante entender o que ela pretende produzir: ajudar a criança a se comunicar melhor, ampliar sua autonomia, reduzir sofrimento, apoiar a família, facilitar a vida escolar — ou principalmente fazer a criança parecer mais normal? Essa diferença importa.

Desenvolvimento ≠ Adaptação Forçada

A psicanálise não é contra o desenvolvimento da criança. Ela é contra transformar desenvolvimento em adaptação forçada. O objetivo do cuidado não deve ser fabricar uma criança obediente. Deve ser construir condições para que ela encontre modos menos sofridos de estar no mundo.

Promessas que Alertam

Sempre que uma terapia promete "corrigir", "normalizar", "reduzir tudo", "eliminar sinais" ou "treinar comportamentos", a família precisa parar e pensar. O problema não é a criança ser diferente — o problema é quando o mundo só aceita a criança se ela parecer igual.

Perguntas que Protegem a Criança

Uma família não precisa dominar termos técnicos para conversar com profissionais. Ela só precisa ter direito de perguntar — e profissionais sérios devem acolher perguntas. Antes de iniciar qualquer tratamento, é importante questionar:

Sobre a Intervenção

- Qual é o objetivo dessa intervenção?
- Por que ela está sendo indicada para meu filho?
- Que resultados vocês esperam?
- Como esses resultados serão avaliados?
- O que acontece se meu filho recusar?
- A recusa dele será escutada ou vencida?

Sobre o Cuidado

- Como vocês percebem sofrimento?
- Quais sinais indicam que a intervenção está fazendo mal?
- Existe possibilidade de reduzir horas ou mudar o plano?
- Meu filho terá tempo para brincar sem meta?
- Os interesses dele serão usados como apoio ou apenas como recompensa?
- Os objetos importantes para ele serão respeitados?

Sobre a Família

- A família será orientada ou culpabilizada?
- Vocês reconhecem limites nesse método?

Essas perguntas são simples, mas poderosas. Elas mostram que a família não está ali apenas para obedecer — está ali para participar da construção do cuidado. Uma boa intervenção deve conseguir explicar seus objetivos de modo claro, dizer o que sabe e também o que não sabe, reconhecer riscos, aceitar revisão e considerar a resposta da criança. **Se uma clínica ou profissional trata toda pergunta como ameaça, isso é um sinal de alerta. Cuidado sério suporta diálogo. Cuidado ético não precisa de intimidação. Cuidado verdadeiro não começa calando a família.**

O Direito de Observar a Criança

Muitas famílias são ensinadas a olhar apenas para os resultados: a criança falou mais palavras, sentou por mais tempo, respondeu a mais comandos, reduziu crises, aceitou mais atividades, obedeceu melhor. Tudo isso pode parecer evolução — mas a família precisa observar mais do que isso.

O que observar além do comportamento

- A criança está mais tranquila? Está dormindo melhor?
- Está menos angustiada? Mais espontânea?
- Está brincando? Buscando contato à sua maneira?
- Está encontrando formas próprias de comunicar?
- Está mais segura? Está mais viva?

Ou está apenas mais quieta? Essa diferença é fundamental.

Sinais que pedem atenção

Uma criança pode parar de gritar porque encontrou outro modo de expressar sofrimento — isso pode ser avanço. Mas também pode parar de gritar porque aprendeu que não adianta manifestar dor. Uma criança pode olhar mais porque o olhar se tornou uma forma possível de laço — mas também pode olhar porque foi treinada a obedecer.

Se a criança fica mais assustada, mais apagada, mais irritada, mais sem iniciativa ou mais dependente de comandos, isso precisa ser conversado. Não aceite que tudo seja explicado como "fase", "birra", "resistência" ou "fuga de demanda". Às vezes, a criança está dizendo que algo não vai bem.

A psicanálise ensina que muitos sinais da criança têm função. Uma recusa, uma repetição, um objeto, um silêncio ou uma crise podem dizer algo sobre como ela tenta se defender do excesso. A família deve prestar atenção quando algo muda demais — e tem o direito de escutar esse sinal.

Quando Continuar, Quando Ajustar, Quando Parar

Nenhuma intervenção deveria ser intocável. Todo tratamento precisa poder ser avaliado. **Continuar** pode ser importante quando a criança demonstra sinais de bem-estar, ampliação de recursos e menos sofrimento. **Ajustar** pode ser necessário quando a intervenção produz alguns efeitos positivos, mas também sinais de cansaço, resistência ou excesso. **Parar** pode ser necessário quando a criança piora, sofre, se apaga, entra em pânico, perde vitalidade ou passa a viver a intervenção como invasão.

Sinais de Alerta

A criança começa a dormir muito pior; fica mais irritada depois das sessões; chora ou se desespera antes de ir; se retrai diante de determinado profissional; perde espontaneidade; fica dependente demais de comandos; parece mais obediente, mas menos viva; passa a apresentar medo de errar; demonstra sofrimento que não é escutado; tem seus objetos ou defesas retirados de forma brusca.

O que uma boa equipe deve perguntar

Uma boa equipe não deve culpar a criança nem a família quando surgem dificuldades. Deve perguntar: o que não está funcionando? O que está excessivo? O que precisa ser reduzido? O que precisa ser modificado? O que a criança está tentando mostrar? O que a família está percebendo?

Insistir nem sempre é virtude

Na clínica, insistir nem sempre é virtude. Às vezes, insistir é violentar. Cuidado exige direção, mas também exige limite. Quando uma intervenção não aceita pausa, revisão ou interrupção, ela deixa de ser cuidado e se aproxima de imposição.

Esses sinais não significam automaticamente que toda intervenção é ruim — mas significam que algo precisa ser revisto.

A Escola Também Precisa Ser Interrogada

A escola costuma ser um dos maiores desafios para a família. Muitas mães escutam reclamações todos os dias: a criança não acompanha, não senta, não copia, não interage como esperado, não obedece à rotina, não participa das atividades, não fica quieta, não brinca como as outras. A escola pode pedir laudos, relatórios, acompanhante, orientações e terapias — algumas dessas demandas podem ser legítimas. Mas a família precisa fazer uma pergunta importante: **a escola está tentando incluir ou apenas adaptar a criança à força?**



Inclusão Verdadeira

Inclusão não é fazer a criança autista parecer igual às outras. É construir condições para que ela possa participar sem ser esmagada. Isso pode exigir mudanças no ambiente, na rotina, na comunicação, nas atividades, no tempo de permanência, no modo de apresentar tarefas e na forma como os adultos interpretam suas recusas. A criança não deve ser a única a se adaptar — a escola também precisa se transformar.



O que observar na escola

Do ponto de vista da psicanálise, a presença da criança na escola não pode ser reduzida à obediência. É preciso observar como ela faz laço, como se aproxima dos colegas, como usa objetos, como responde ao excesso de barulho, como suporta as transições e como encontra pequenos caminhos de participação.



Perguntas para a escola

O que vocês já adaptaram no ambiente? Como identificam sinais de sofrimento? Como lidam com crises? Há espaço de pausa? Meu filho pode se comunicar de outras formas? Vocês observam os interesses dele? O acompanhante está ajudando a incluir ou apenas controlando?

A criança não deve ser incluída apenas no papel. Ela precisa encontrar um lugar possível.

A Mãe Também Precisa de Cuidado

Muitas mães vivem como se não pudessem cair. Precisam cuidar da criança, responder à escola, levar às terapias, lidar com médicos, organizar documentos, brigar com plano de saúde, explicar para familiares, administrar crises, estudar sobre autismo, trabalhar, cuidar da casa — e sorrir quando estão destruídas. E ainda escutam que precisam fazer mais: mais estímulo, mais rotina, mais organização, mais firmeza, mais paciência, mais treino em casa, mais adesão. O sofrimento da mãe muitas vezes fica sem lugar.

A mãe também é sujeito

Mas cuidar de uma criança autista não deveria significar o apagamento da mãe. Ela tem medo, tem culpa, tem raiva, tem tristeza, tem desejo, tem limites, tem história. Tem direito de não saber, de descansar, de falar. Uma mãe esmagada não cuida melhor. Uma mãe culpada não pensa melhor. Uma mãe aterrorizada não decide melhor.

Por isso, qualquer plano de cuidado que ignora a mãe está incompleto. A família precisa se perguntar: quem escuta quem cuida? Quem sustenta essa mãe? Quem permite que ela fale sem ser julgada? Quem ajuda a separar cuidado de culpa? Quem lembra que ela não precisa ser perfeita?

A contribuição da psicanálise

A psicanálise oferece aqui uma contribuição importante: abrir espaço para a palavra da mãe. Não para culpabilizá-la — mas para escutá-la como sujeito diante de uma experiência difícil, intensa e muitas vezes solitária.

Cuidar de quem cuida também é cuidar da criança.

Decidir com Liberdade Não É Decidir Sozinho

Este livro critica o discurso único, mas não defende que a família fique sozinha. Famílias precisam de profissionais — médicos responsáveis, terapeutas éticos, escolas preparadas, políticas públicas, direitos garantidos, apoio. A questão não é recusar todo saber profissional. A questão é não transformar nenhum saber em autoridade absoluta.

→ **Escutar sem ser ameaçado**

Decidir com liberdade não significa decidir sem orientação. Significa poder escutar orientações sem ser ameaçado, poder comparar caminhos, poder fazer perguntas, poder dizer "isso não serve para meu filho".

→ **Poder rever e discordar**

Significa poder rever uma decisão, poder discordar de um profissional sem ser tratado como negligente, poder incluir a percepção da família no plano de cuidado, poder reconhecer que uma criança não é igual a outra.

→ **Uma boa equipe trabalha com a família**

Uma boa equipe deve trabalhar com a família, não sobre a família. Deve explicar, escutar, adaptar, reconhecer limites, aceitar que a criança responda de modo inesperado e rever o plano quando necessário. O cuidado precisa ser construído em rede — mas rede não é prisão. A rede deve sustentar a criança e a família, não capturá-las.

Se a família sente que perdeu completamente o direito de pensar, algo está errado. O cuidado deve aumentar a possibilidade de vida — não diminuir a liberdade.

Um Roteiro Simples para Avaliar Qualquer Proposta

Antes de aceitar uma proposta de tratamento, a família pode usar este roteiro. Esse roteiro não substitui avaliação profissional — mas ajuda a família a não entregar sua criança a qualquer discurso de autoridade.

01

Entenda o objetivo

O que essa intervenção quer produzir? Comunicação? Autonomia? Redução de sofrimento? Apoio escolar? Organização corporal? Ampliação do laço? Ou apenas obediência?

02

Observe a criança

Ela parece mais segura, mais tranquila, mais viva? Ou mais apagada, assustada e dependente?

03

Pergunte pelos limites

O profissional admite que o método pode não funcionar para todos? Admite riscos? Admite mudanças? Admite parar?

04

Veja como a recusa é tratada

A recusa da criança é escutada como sinal ou combatida como problema?

05

Avalie a carga

A rotina permite descanso, brincadeira, convivência familiar e tempo livre? Ou a infância virou agenda terapêutica?

06

Observe a família

A mãe está sendo escutada ou apenas cobrada? A família recebe apoio ou culpa?

07

Desconfie de promessas absolutas

Frases como "único método", "resultado garantido", "sem isso não há futuro" e "não questione a ciência" devem acender alerta.

08

Veja se há espaço para a singularidade

Os interesses, objetos, ritmos e formas próprias da criança são respeitados? Ou tudo precisa ser corrigido?

09

Pense no laço

A intervenção ajuda a criança a se relacionar de modo possível? Ou apenas aumenta respostas automáticas?

10

Permita revisão

Nenhuma decisão precisa ser eterna. Cuidado responsável pode mudar de direção.

> A pergunta principal permanece: **isso está ajudando meu filho a viver melhor ou apenas a parecer mais adequado?**

Escolher Sem Obedecer ao Medo

Ao longo deste livro, uma ideia foi repetida de várias formas: a família precisa recuperar o direito de pensar. Pensar não é abandonar a criança. Questionar não é negar a ciência. Duvidar não é negligenciar. Pedir explicações não é atrapalhar o tratamento. Observar sofrimento não é resistir à orientação profissional. A mãe não precisa aceitar o medo como conselheiro — o medo pode até aparecer, é compreensível, mas não deve governar a decisão.

O que a criança precisa

A criança autista não precisa ser salva de si mesma. Ela precisa ser acompanhada em sua forma singular de existir. Precisa de cuidado, sim — mas cuidado não é normalização, não é apagar diferenças, não é quebrar recusas, não é transformar toda infância em treinamento, não é fazer a criança caber no ideal dos adultos.

O que é cuidar

Cuidar é escutar. É proteger. É sustentar. É adaptar o mundo também. É reconhecer limites. É construir laços possíveis. É respeitar o corpo. É permitir invenções. É ajudar a criança a sofrer menos sem exigir que ela deixe de ser quem é.

A posição deste livro

Este livro não oferece uma receita pronta. Ele oferece uma posição: a de não entregar a criança ao discurso único, de não confundir ciência com propaganda, de não confundir intensidade com cuidado, de não confundir obediência com evolução, de não confundir adaptação com vida.

> No fim, a pergunta mais importante não é qual método venceu a disputa. A pergunta mais importante é: **essa criança está sendo escutada?** Se a resposta for não, é preciso parar. Porque antes de qualquer técnica, antes de qualquer relatório, antes de qualquer protocolo, existe uma criança — e essa criança não é um problema a ser corrigido. É um sujeito a ser encontrado.

Referências

Centers for Disease Control and Prevention. (2025, May 27). *Data and statistics on autism spectrum disorder*. U.S. Department of Health and Human Services. https://www.cdc.gov/autism/data-research/index.html

Centers for Disease Control and Prevention. (2025, May 20). *Autism prevalence varies across US communities*. U.S. Department of Health and Human Services. https://www.cdc.gov/autism/articles/prevalence-varies-across-us-communities.html

Department of Defense. (2024). *Evaluation of the TRICARE Program: Fiscal year 2024 report to Congress*. Military Health System. https://health.mil/reference-center/reports/2024/09/23/annual-evaluation-of-the-tricare-program-fy24

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2025, May 23). *Censo 2022 identifica 2,4 milhões de pessoas diagnosticadas com autismo no Brasil*. Agência IBGE Notícias. https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/43464-censo-2022-identifica-2-4-milhoes-de-pessoas-diagnosticadas-com-autismo-no-brasil

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2025). *Censo 2022 contou 2,4 milhões de pessoas diagnosticadas com autismo no Brasil*. IBGE Educa. https://educa.ibge.gov.br/criancas/brasil/2697-ie-ibgeeduca/jovens/materias-especiais/22700-censo-2022-contou-2-4-milhoes-de-pessoas-diagnosticadas-com-autismo-no-brasil.html

Kupferstein, H. (2018). Evidence of increased PTSD symptoms in autistics exposed to applied behavior analysis. *Advances in Autism, 4*(1), 19–29. https://doi.org/10.1108/AIA-08-2017-0016

Reichow, B., Hume, K., Barton, E. E., & Boyd, B. A. (2018). Early intensive behavioral intervention (EIBI) for young children with autism spectrum disorders (ASD). *Cochrane Database of Systematic Reviews, 2018*(5), Article CD009260. https://doi.org/10.1002/14651858.CD009260.pub3

TRICARE. (2025). *Autism Care Demonstration*. https://www.tricare.mil/autism

TRICARE. (2025, April 3). *Autism Care Demonstration overview*. https://www.tricare.mil/About/Regions/West-Region/Find-Care/Autism-Care-Demonstration

Sinopse

Este e-book foi escrito para mães, pais e familiares de autistas que desejam compreender o que raramente lhes é dito. Em vez de aceitar passivamente o discurso único sobre diagnóstico e tratamento, o leitor é convidado a examinar criticamente os interesses, as promessas e os silêncios que cercam o campo do autismo. Partindo da psicanálise, a obra mostra como certos saberes se impõem como verdades absolutas, enquanto questões fundamentais sobre sofrimento, singularidade e cuidado permanecem ocultas. Ao longo dos capítulos, o livro oferece uma leitura acessível, crítica e didática para ajudar as famílias a decidir sem medo, sem culpa e com mais liberdade.



Sobre o Autor

Lucio Escobar é Doutor em Psicanálise pela Logos University International – França, Pós-graduado em Filosofia contemporânea pela faculdade Iguaçu, Pós-graduado em Psicologia fenomenológica existencial pela Faculdade Iguaçu, Pós-graduado em Psicanálise pela Faculdade de Ciências médicas e jurídicas – FACMED, Graduado Em Filosofia e Antropologia pela Logos University International – EUA.

Email: escobarpsiba@gmail.com

ORC ID: 0000-0002-3430-5094